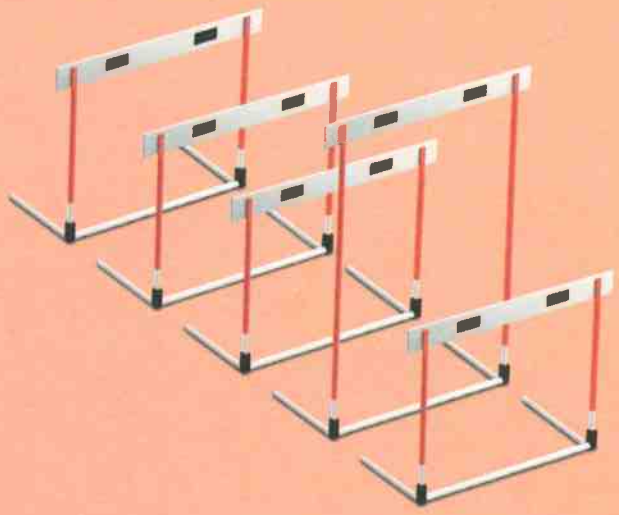

M. Lancini, L. Cirillo
T. Scodeggio, T. Zanella

L'adolescente

Psicopatologia e psicoterapia evolutiva

Raffaello Cortina Editore

I

DOLORE EVOLUTIVO

PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PER ADOLESCENTI IN CRISI

NUOVE NORMALITÀ E NUOVE PATOLOGIE

La diagnosi, la valutazione del funzionamento psichico, il setting della consultazione e della psicoterapia in adolescenza rappresentano, da sempre, temi di grande interesse, intorno ai quali si sono sviluppati importanti dibattiti e orientamenti, che hanno condotto a sperimentare tecniche del colloquio e a predisporre dispostivi clinici anche molto differenti tra loro. La responsabilità che ogni processo diagnostico e di presa in carico meriterebbe da parte del clinico, e di qualunque istituzione pubblica o privata, risulta ancor più importante se coinvolge pazienti minorenni o, comunque, in età evolutiva. La necessità di effettuare una diagnosi condivisibile, e di potersi confrontare scientificamente rispetto all'inquadramento psichico e alle modalità di presa in carico più efficaci, non dovrebbe mai avere il sopravvento sulle esigenze dei nostri interlocutori. Ragazzi e ragazze sofferenti, madri e padri addolorati, tutti con una storia unica e irripetibile che merita il massimo rispetto, i quali decidono di rivolgersi con coraggio, fiducia e speranza a professionisti e istituzioni psico socio sanitarie, alla ricerca di aiuto più che di una diagnosi. In questo ambito, i dibattiti teorici e i confronti relativi alla teoria della tecnica sono particolarmente articolati, oltre che numerosi. Anche limitando il campo esclusivamente alla nostra formazione psicoanalitica, esistono molteplici modi di approcciarsi alle vicende dello sviluppo individuale, diversi modelli interpretativi del funzionamento conscio e inconscio dell'essere umano, da cui derivano differenti modalità di declinazione dei processi diagnostici, di consultazione e psicoterapia e di organizzazione del setting della presa in carico del paziente. L'adolescenza poi, come seconda nascita, costituisce una fase particolarmente delicata

e complessa. La mobilità e la fluidità di un'epoca della vita umana più di altre caratterizzata da incertezza e instabilità psichica, corporea e relazionale costringono a muoversi con grande cautela di fronte ai segnali di crisi di ragazze e ragazzi. L'adolescente fluttua all'interno di un quadro evolutivo che richiede un'attenzione specifica rispetto al riconoscimento delle situazioni a rischio e psicopatologiche, peraltro condizionato anche dalle continue metamorfosi dei miti affettivi, sociali e antropologici in cui nascono e crescono le diverse generazioni. Se i concetti di normalità e di patologia variano nelle diverse epoche storiche, in base alle trasformazioni culturali, tecnologiche e dei sistemi rappresentativi della popolazione, è facile comprendere quanto questo aspetto coinvolga, a maggior ragione, l'approccio a ciò che è da considerarsi normale o il segnale di una psicopatologia in quella fase evolutiva e, in qualche modo, sempre creativa e innovativa che è l'adolescenza. In estrema sintesi, ciò che in uno stesso momento storico può essere considerato normale o psicopatologico dipende non solo dalla cultura, dal territorio, dal continente e dalla nazione in cui avviene la rilevazione, ma anche dall'epoca che ogni singola generazione di adolescenti sta attraversando, la quale richiede continue rimodulazioni dello scenario di definizione di psicopatologia. Per fare un esempio tra i più attuali e complessi: oggi in base a quali criteri e variabili possiamo stabilire se, all'interno della nostra società occidentale, l'utilizzo dei device connessi a Internet da parte di un adolescente segnala un disagio, la manifestazione di aspetti regressivi, una dipendenza patologica o piuttosto una nuova normalità, anzi un comportamento adattivo, che sostiene la realizzazione dei compiti di sviluppo fase-specifici? Basta dare uno sguardo agli item dei test ancora oggi più utilizzati nelle ricerche della comunità scientifica, per comprendere quanto sia stato difficile, negli ultimi decenni, individuare e validare variabili capaci di definire e inquadrare la dipendenza da Internet da parte di adolescenti per cui risulta già da tempo obsoleta anche la definizione di "nativi digitali".

AFFETTI E COMPITI EVOLUTIVI

In questa complessità, il nostro modello teorico si ispira alle teorie di Franco Fornari riadattate e riviste in base agli studi che, in oltre trentacinque anni di lavoro, hanno visto l'Istituto Minotauro e i suoi soci impegnati in attività clinica e di ricerca con adolescenti di diverse generazioni. A partire da una personale rilettura dell'opera freudiana e

kleiniana, Franco Fornari (1983) ha elaborato e messo a punto un'originale teorizzazione psicoanalitica, inizialmente denominata "teoria coinemica" e successivamente riformulata come "teoria dei codici affettivi" (Maggiolini, 1988), che si fonda su una concezione dell'inconscio come centrale di simbolizzazione. Si tratta di un modello semeiotico che sottolinea la tendenza umana a significare in nome del principio della sopravvivenza della specie, a fronte di altri modelli teorici che, invece di privilegiare una concezione dell'uomo come animale simbolico, ne sottolineano altri aspetti, per esempio, pulsionali o relazionali. In questa teorizzazione, ai concetti di codice affettivo e ruolo affettivo si affianca quello di compito affettivo, che si definisce in funzione dei compiti evolutivi correlati alle diverse fasi del ciclo di vita individuale e familiare. Il modello della famiglia interna, come insieme di ruoli affettivi con propri compiti e valori ideali, sostiene così una concezione dei conflitti psichici da inquadrare in una prospettiva che non si focalizza esclusivamente su quelli originatisi durante l'infanzia, ma soprattutto su quelli interni ai ruoli familiari, nei diversi momenti del ciclo di vita dei suoi membri (Maggiolini, Pietropolli Charmet, 1995). In questa prospettiva, quindi, l'inconscio non solo non si nasconde, ma aiuta l'individuo a trovare la strada per la sopravvivenza. A partire dalle centrali simboliche, l'essere umano è in grado di simbolizzare, di trasformare il proprio corpo in pensieri e parole, di dare senso a ciò che gli accade. Si tratta, dunque, di un modello che coniuga teoria psicoanalitica e teoria evolutiva, che poggia sulla visione di un inconscio salvifico, che tende a manifestarsi, e in cui sono centrali i concetti di simbolizzazione e decisione affettiva. Inoltre, il disagio, la crisi, la sofferenza mentale non sono collocati nella persona, ma sono da ricercare nell'intreccio tra l'individuo, i propri bisogni evolutivi e il contesto, la cultura affettiva, l'ambiente in senso ampio, in cui è immerso (Maggiolini, 2009).

In adolescenza si manifesta, in modo particolarmente significativo, la necessità di nuovi processi di simbolizzazione, più evoluti rispetto a quelli dell'infanzia, poiché l'individuo deve giungere alla conquista del vero Sé. A partire dalle novità innescate dalle trasformazioni corporee e cognitive, l'adolescente è chiamato a realizzare dei compiti evolutivi originali, talmente esigenti e specifici da meritare un'attenzione diagnostica particolare. La crisi in adolescenza non può essere inquadrata ricorrendo esclusivamente a quanto accaduto nelle fasi di vita precedenti, in una sorta di determinismo psichico infantile. Il disagio e la sofferenza adolescenziali dipendono molto da quanto sta accadendo – o non accadendo – ora, nel processo trasformativo in atto, e il dolore deriva dalla

percezione del ritardo che si sta accumulando e dalla visione di un futuro incerto, che in alcuni casi può divenire perdita della speranza in un futuro possibile. In questa prospettiva, la crisi adolescenziale non dovrebbe mai essere considerata come il semplice proseguimento di una psicopatologia infantile e neanche come il segnale di avvio di una psicopatologia adulta. L'adolescenza è una fase del ciclo di vita con una propria dignità, che merita processi diagnostici, valutativi e clinici specifici.

I compiti evolutivi fase-specifici dell'adolescenza possono essere considerati invarianti, ovvero indipendenti dal contesto storico in cui un individuo vive, anche se le trasformazioni sociali e culturali influenzano in modo decisivo le modalità attraverso le quali si affrontano i compiti evolutivi e si soffre come adolescenti (Lancini, 2010, 2015, 2017, 2020). Nel nostro modello teorico i compiti evolutivi sono quattro (Pietropolli Charmet, 1990, 1991; Lancini, Turuani, 2009), anche se nell'applicazione clinica, come vedremo, ci si riferisce prevalentemente a tre aree dello sviluppo in scacco, considerando la quarta in qualche modo trasversale alle altre tre. I compiti evolutivi adolescenziali sono: il processo di separazione-individuazione, la mentalizzazione del Sé corporeo, la nascita sociale e la definizione e la formazione di valori.

■ *Separazione-individuazione.* L'adolescente è chiamato a rendersi progressivamente indipendente, a livello intellettuale e affettivo, dalle figure reali dei genitori e dalle loro rappresentazioni mentali e idealizzate. Questo processo è complesso perché richiede di rinunciare ai vissuti di protezione e di idealizzazione del proprio Sé che la presenza onnipotente genitoriale dell'infanzia garantiva. Le trasformazioni in atto suggeriscono all'adolescente di investire in altre direzioni, distanziandosi dall'appartenenza affettiva primaria e dal clima emotivo originario, per poter evolvere e sopravvivere psichicamente. In realtà questo processo è vissuto in modo ambivalente dall'adolescente, che sente ancora forte il richiamo di un'intesa straordinaria e profonda, mai più sperimentabile, con una, o entrambe, le figure genitoriali, molto spesso con la propria madre. Nella separazione dalla nicchia affettiva primaria, quindi, il ragazzo o la ragazza sperimentano intensi vissuti di perdita, luttuosi, in qualche modo depressivi. Per questa ragione è importante non semplificare le difficoltà separative degli adolescenti, attribuendo esclusivamente alle responsabilità materne e/o paterne l'impossibilità di separarsi, individuarsi e soggettivarsi da parte del figlio. Si tratta di dinamiche estremamente complesse, che spesso dipendono anche dalla tendenza dell'adolescente a richiamare sulla scena la madre, o il padre, attraverso

comportamenti e agiti, che rieditano la richiesta del legame originario a soddisfacimento di bisogni vecchi, ma evidentemente ancora attuali. Per semplificare drammaticamente, attraverso un esempio tra i più frequenti nell'analisi dei casi portati in supervisione nelle formazioni o nelle scuole di specializzazione, se un adolescente dorme ancora nel lettone della mamma, non conviene mai interpretare il fenomeno riducendolo a un'esigenza, a una responsabilità, o addirittura a una colpa esclusivamente materna o di assenza paterna. Negli ultimi anni poi, i processi separativi e individuativi degli adolescenti non avvengono più attraverso quelle tendenze oppositive e trasgressive, tipiche delle epoche precedenti. Le trasformazioni dei modelli educativi familiari in direzione affettiva e relazionale, la riduzione della componente sessuofobica, la società dell'individualismo e di Internet sono solo alcuni dei fattori che hanno contribuito a rendere il passaggio adolescenziale sempre più connotato in termini narcisistici piuttosto che edipici. Oggi il processo separativo dell'adolescente dalla nicchia affettiva primaria, e dalle rappresentazioni interiorizzate in infanzia, avviene per delusione e non più per trasgressione.

■ *Mentalizzazione del Sé corporeo.* I cambiamenti innescati dalla pubertà, a partire dal menarca o dalla comparsa del liquido seminale, richiedono un imponente lavoro mentale da parte dell'adolescente. Il corpo cambia biologicamente, ma non è sufficiente assistere alla trasformazione in atto per assolvere a questo compito evolutivo. L'adolescente è chiamato ad accogliere e a integrare in una nuova immagine di sé le trasformazioni fisiche imposte dalla natura e dal destino. Il corpo dell'adolescente ha nuove dotazioni tutte da accettare, studiare e allenare. Un compito non facile da assolvere, se è vero che un numero sempre più significativo di adolescenti manipola, rifiuta o ripudia il corpo nelle sue fattezze naturali, toccate in sorte. Come è noto, a partire dalle tradizioni della storia psicoanalitica, le difficoltà nel processo di mentalizzazione del nuovo corpo in adolescenza deriverebbero dal passaggio da uno stato in qualche modo indifferenziato, a quello di soggetto sessualmente maturo e potenzialmente generativo. Negli ultimi anni, però, le difficoltà legate alla necessità di accettare le nuove componenti pulsionali, erotiche e generative, sembrerebbero aver lasciato sempre più spazio a problematiche connesse alle aspettative ideali di bellezza, sollecitate da canoni estetici sempre più esigenti. La sessualità e la rinuncia all'onnipotenza in nome della complementarietà con il corpo dell'altro appaiono oggi meno decisive nella psicodinamica del disagio corporeo

di ragazze e ragazzi. L'adolescente ha attraversato un'infanzia caratterizzata dall'anticipazione della pubertà psichica sulla pubertà fisica, abbigliandosi da piccolo uomo o da piccola donna molto precocemente, ispirandosi ai canoni proposti dai più giovani, ma soprattutto dalla cultura, o sottocultura, estetica, performante, ritoccata, "make-up", proposta dalla società massmediatica e di Internet. Meno sesso, più sexting e selfie, insieme alla scomparsa dell'amore romantico a favore di quello narcisistico, testimoniano come il corpo erotico abbia ceduto quote significative al corpo estetico e alla sua visibilità. Anche la generatività è connotata in modo molto diverso, sempre più procrastinata nella storia dei propri genitori e in qualche modo stravolta dalle nuove opportunità offerte dalla fecondazione artificiale e dalla procreazione assistita, che non rendono più indispensabile l'atto sessuale ai fini procreativi. Quasi sempre, l'adolescente odierno incontra, insieme all'arrivo del nuovo corpo, la sensazione di non essere mai sufficientemente bello e popolare. Il corpo è brutto, goffo e impresentabile, non peccaminoso. Infine, non si dovrebbe mai dimenticare che le trasformazioni corporee innescate dalla pubertà costringono l'individuo a fare i conti con la propria mortalità. La conoscenza della morte trova, infatti, nella mentalizzazione del Sé corporeo un'occasione ineludibile di avvicinamento a una nuova prospettiva che cambia la vita e di non facile accettazione: il corpo di cui si è dotati ha un limite temporale, morirà. Il corpo, insieme ai cambiamenti cognitivi in atto, costringe l'adolescente a fare i conti con questa verità, che spinge a reazioni diverse e che dona significato al tentativo di sfidarla e tentare di controllarla attivamente, come avviene nelle innumerevoli modalità attraverso cui i giovani rischiano la vita. L'adolescente tenta la morte non perché si sente onnipotente e invincibile, ma per il motivo opposto, ha scoperto di essere mortale.

■ *Nascita sociale*. Oggi in adolescenza si è chiamati, in modo più significativo rispetto al passato, ad assumersi direttamente la responsabilità di un ruolo socialmente riconosciuto, che consenta di progettare e di agire in direzione della possibile realizzazione del proprio futuro. La spinta alla nascita sociale coinvolge, in particolar modo, la relazione con i coetanei e con la scuola. Infatti, nel contesto odierno, anche a seguito della scolarizzazione di massa e dell'innalzamento dell'obbligo, la scuola si è costituita come ambiente privilegiato di sperimentazione del proprio ruolo sociale. Ne esistono certamente altri, come per esempio l'ambito sportivo, musicale, scoutistico o alcune forme di volontariato, ma è soprattutto a scuola che la maggior parte degli adolescenti sperimenta le più importanti esperienze di gratificazione e di mortificazione sociale. Pur se in modo ambivalente, è nei riguardi della scuola che l'adolescente esprime tratti importanti del processo di valorizzazione di sé come individuo immerso nella società. Negli ultimi decenni, la rappresentazione adolescenziale della scuola si è molto modificata. L'esperienza scolastica non solo non ha perso importanza, ma ne ha assunta una maggiore, declinandosi sempre di più come vicenda iperinvestita di significati affettivi e relazionali piuttosto che come luogo elettivo dell'apprendimento e della formazione culturale. La destituzione del valore simbolico del docente e del dirigente scolastico, la dipendenza sempre più marcata dallo sguardo di ritorno dei compagni di classe e d'istituto, la richiesta, più o meno esplicita, di risposte credibili sull'utilità della scuola come esperienza significativa per lo sviluppo attuale e futuro del Sé adolescenziale, sono solo alcuni dei tratti più rilevanti della trasformazione del modo di intendere l'avventura scolastica da parte delle nuove generazioni. La scuola è ricercata come ambito relazionale, di socializzazione e di valorizzazione del nascente Sé adolescenziale. Allo stesso tempo è aumentato a dismisura il potere orientativo dei coetanei, da sempre già particolarmente significativo in adolescenza, allorquando la spinta all'appartenenza gruppale e generazionale non è più differibile. Immersi in un bagno relazionale sin dalla primissima infanzia e cresciuti nell'immaginario del successo planetario reso possibile da Internet, gli adolescenti odierni dipendono in modo estremo dallo sguardo di ritorno dei coetanei e soffrono enormemente per la mancanza di popolarità a scuola e nel gruppo.

■ *Definizione-formazione di valori*. L'adolescenza rappresenta una fase decisiva per lo sviluppo e la messa a punto dei valori di riferimento che orientano le azioni individuali. A partire dalla necessità di definire i propri valori dell'identità di genere maschile o femminile, l'adolescente è impegnato nella costruzione e nel perfezionamento di un proprio senso etico, di principi e ideali personali. Questo percorso si dipana attraverso l'incontro con soggetti, alternativi ai genitori, portatori di diversi modelli di riferimento, dai quali si assorbono nuovi principi che contribuiscono a formare il proprio sistema etico e valoriale. Gli amici, così come altri adulti, quali, per esempio, un insegnante, un allenatore sportivo, un operatore del privato sociale, un amico di famiglia o un parente, si costituiscono come modelli di identificazione. L'adolescente è chiamato a effettuare una sintesi di tutti i processi di identificazione e dei modelli imitativi con i quali entra in contatto, per giungere alla definizione del

proprio unico e specifico sistema valoriale di riferimento che ne orienta le scelte e le azioni. La costruzione degli ideali adolescenziali va di pari passo con una ridefinizione complessiva del senso di sé, del proprio carattere e del proprio mito affettivo. Negli ultimi anni questo percorso ha subìto l'influenza di diversi fattori, a partire dall'infanzia dell'adolescente. Oggi i bambini, sin dalla più tenera età, subiscono il condizionamento di pervasivi modelli di identificazione alternativi a quelli familiari e scolastici. Se in passato i genitori e gli insegnanti rappresentavano i referenti quasi esclusivi dei processi identificatori infantili, la quotidianità odierna ci restituisce una realtà molto più complessa e articolata. Oltre che dall'assidua frequentazione di molti coetanei, l'infanzia degli adolescenti è stata costellata dalla presenza del marketing, di canali monotematici dedicati ai cartoni animati, dalla cultura dell'individualismo, dell'audience e della caduta del confine tra esperienza pubblica e privata, proposta full time da Internet e dai mass media. Oggi, la famiglia e la scuola, le più importanti agenzie educative, propongono i propri modelli di identificazione in una società abitata da molti più competitor, impegnati a offrire, dalla culla all'adolescenza, un imponente materiale valoriale che incide sullo sviluppo degli ideali personali e generazionali. Inoltre, l'adolescente odierno costruisce il proprio percorso identitario secondo riferimenti al genere maschile e femminile meno rigidi, più fluidi; espressioni come eterosessualità, bisessualità, omosessualità, pansessualità e asessualità hanno oggi una declinazione molto diversa rispetto al passato per buona parte della popolazione giovanile.

SINTOMI CHE PARLANO

Nella realizzazione di questi compiti evolutivi l'adolescente attiva nuovi processi di simbolizzazione e capacità riflessive che possono sostenerlo nell'elaborazione del lutto per la separazione dagli oggetti primari e dal Sé onnipotente infantile, nell'integrazione delle nuove dotazioni corporee nell'immagine mentale di sé, nell'individuazione dei valori di riferimento ai quali affidare la regia della crescita e della nascita sociale. Più in generale, l'adolescente deve realizzare una complessa sintesi tra le istanze provenienti dalla multiforme popolazione dei Sé che siedono nel proprio parlamento interno, esprimendo visioni non tutte favorevoli alla crescita. Nella nostra prospettiva la crisi adolescenziale rappresenta, quindi, un ritardo, un blocco, uno scacco nella realizzazione dei compiti evolutivi, piuttosto che un segnale di psicopatologia, in una fase in cui

il percorso identitario non si è ancora consolidato. In questo senso, il mantenimento del contatto con il principio di realtà costituisce, ovviamente, un discrimine importante nel quadro sintomatico complessivo.

Il sintomo, che spesso in adolescenza si esprime attraverso l'agito, rappresenta una manifestazione del disagio evolutivo, sostenuta dall'inconscio umano come portatore di aspetti salvifici e di una tendenza a mostrarsi per dare senso a quanto sta accadendo, o non accadendo, al fragile essere umano. Il sintomo svolge una duplice funzione: Da un lato segnala il disagio, comunica il dolore, la profonda sofferenza individuale. Per questo l'adulto è chiamato a intervenire, non banalizzando mai alcun segnale di richiesta d'aiuto proveniente da ragazzi e ragazze. Qualsiasi agito dell'adolescente è una manifestazione sintomatica da prendere molto sul serio, al di là della gravità oggettiva dell'azione compiuta, motivo per cui andrebbe abolita la frase troppe volte sentita "è stato un gesto dimostrativo". Sicuramente lo è stato e per questo bisogna drammatizzarlo, onde evitare che l'adolescente lo ripeta in modo più drastico e violento. Dall'altra parte, il sintomo rappresenta la personalissima modalità di autosomministrarsi una prima forma di cura, un'automedicazione urgente, messa in atto per mitigare un dolore mentale insopportabile, che rischia di portare alla follia. L'inconscio umano spinge a fare di tutto pur di non perdere il senno, pur di non cadere nella tentazione di rifugiarsi in una realtà parallela. Davanti alla crisi evolutiva ogni adolescente trova una strada del tutto personale per manifestare il dolore, una soluzione sintomatica che dipende dal proprio specifico funzionamento psichico, affettivo e relazionale. Il sintomo è una difesa dal dolore che rischia di spaccare la mente, per questo deve essere contemporaneamente drammatizzato e rispettato. Il sintomo rappresenta per l'adolescente un modo particolare di gestire la propria fragilità, di non essere sopraffatto dal dolore innescato dalla condizione di stallo evolutivo in cui si trova. Provare a togliere prepotentemente il sintomo a un adolescente, senza aver costruito insieme a lui un'alternativa, è davvero un'operazione pericolosa. Il rischio è il tentativo di suicidio o la frattura mentale, il breakdown psicotico, la perdita di contatto con la realtà.

L'agito adolescenziale incarna dunque la manifestazione di un conflitto evolutivo che non si riesce a comunicare e che per questo diventa comportamento. Ma che nome ha questo dolore? Come mai non è possibile trasformarlo in parola? Che cosa rende impossibile esprimerlo diversamente? Per raggiungere clinicamente un adolescente è necessario ascoltarlo attentamente e cercare di comprendere le ragioni che lo hanno portato ad assumere comportamenti apparentemente insensati,

spudorati ed esagerati. Ascoltare, fino ad allearsi con il sintomo, è un'azione indispensabile in avvio di un percorso di consultazione e psicoterapia con l'adolescente. Un'operazione complessa che, come abbiamo detto, non deve essere assolutamente confusa con la banalizzazione del sintomo, con un approccio che traduca il gesto dell'adolescente in una ragazzata. Si tratta, anzi, di drammatizzare, di dare rilevanza al sintomo, ma per fare questo è fondamentale coglierne e riconoscerne le ragioni. Successivamente, se il lavoro clinico e del contesto procederà bene, si potrà osservare una trasformazione del sintomo in espressioni meno esigenti e drammatiche, fino ad assistere alla remissione della sintomatologia o quantomeno a una riduzione qualitativa e quantitativa delle sue manifestazioni. Se non si vuole intervenire secondo paradigmi eccessivamente patologizzanti da un lato, e meramente educativi dall'altro, è utile dare ascolto e ragione al sintomo. La clinica dell'adolescente richiede di raggiungere la mente del paziente là dov'è, con un profondo rispetto per come il soggetto prova a gestire l'insopportabile crisi evolutiva, una quotidianità senza prospettive visibili. Su queste basi è possibile costruire un'alleanza con il giovane paziente che consenta al dispositivo clinico, e agli adulti di riferimento, di avvicinargli le risorse utili alla ripresa evolutiva, alla scoperta del proprio vero Sé e del proprio talento, come unica possibilità per riorganizzare la speranza e investire in un futuro possibile. L'adolescente è fatto così, se non simbolizza, se non riesce a mettere in parole i conflitti evolutivi che lo animano, agisce. Purtroppo, non è possibile impedirglielo, si può però cercare di capire e interpretare il gesto e di aiutarlo a tradurlo in parole che rendano progressivamente l'agito meno urgente, un'azione non più necessaria a garantire la sopravvivenza psichica (Lancini, 2017, 2020).

CRISI EVOLUTIVA

La crisi adolescenziale molto spesso è l'espressione di un ritardo o di uno stallo che riguarda più di un compito evolutivo. Per esempio, nelle crisi scolastiche sono inevitabilmente presenti difficoltà sia nel processo di separazione-individuazione, sia nella nascita sociale, così come la scelta di recludersi volontariamente in casa, da parte del giovane hikikomori, segnala spesso un blocco pervasivo in ogni area evolutiva. Nonostante questo, è possibile individuare attraverso l'espressione sintomatica prevalente nell'adolescente l'area di sviluppo che più di altre sembra essere alla regia della crisi evolutiva, e proprio questo criterio è

quello che ha guidato la redazione di questo testo dove sono presenti, oltre ai capitoli iniziali e a quello conclusivo dedicato agli stati limite, teorizzazioni e casi che si riferiscono a tre aree dello sviluppo in scacco: il processo di separazione-individuazione, la mentalizzazione del corpo e la nascita come soggetto sociale.

Il quarto compito evolutivo, che, come abbiamo visto, riguarda la definizione e la formazione di nuovi valori e ideali di riferimento da parte dell'adolescente, è trattato trasversalmente in quanto strettamente connesso con le aspettative e gli ideali adolescenziali che influenzano le rappresentazioni del giovane paziente in tutte le aree di sviluppo e ne orientano le scelte e le azioni. Gli ideali esigenti e crudeli sono parte costituente delle difficoltà dell'adolescente odierno nella realizzazione del processo di separazione-individuazione, nella costruzione mentale di un'immagine del nuovo corpo e nella nascita sociale. La costruzione degli ideali adolescenziali procede di pari passo con una ridefinizione complessiva del senso di sé, del proprio carattere e dei miti affettivi personali, senza la quale non è possibile soggettivarsi, accettare le originali dotazioni corporee, e, soprattutto, costruire nuovi legami affettivi e ruoli sociali. Anche Gustavo Pietropolli Charmet, a cui si deve la nascita e lo sviluppo della teoria dei compiti evolutivi alla quale facciamo riferimento, nel corso delle sue pubblicazioni transita da un modello teorico caratterizzato da quattro compiti evolutivi (Pietropolli Charmet, 1990, 1991; Pietropolli Charmet, Rosci, 1992) a un'applicazione clinica in cui propone una lettura del disagio adolescenziale riferita a tre compiti evolutivi (Pietropolli Charmet, 2000).

CONSULTAZIONE E PSICOTERAPIA

A partire da questa teoria, all'interno dell'Istituto Minotauro si è sviluppato un modello di consultazione e presa in carico dell'adolescente a orientamento psicoanalitico, che definiamo psicoterapia evolutiva, in cui il cambiamento è concepito più come evoluzione che come cura e alla cui base si trovano i concetti di simbolizzazione, ruolo affettivo e crisi della cultura affettiva di fronte ai compiti evolutivi fase-specifici dell'adolescente (Pietropolli Charmet, 1999, 2000; Maggiolini, Pietropolli Charmet, 2004a; Lancini, 2007; Pietropolli Charmet, Piotti, 2009; Lancini, 2016).

Il presupposto è che la consultazione avvenga in una situazione di scacco evolutivo e di crisi della cultura affettiva dominante, la quale si